3 보건의료 정책 변화

장 석 용
교수 / 연세대학교 보건대학원



보건의료 정책 변화의 큰 흐름

- 공공을 키워드로 한 의료 혁신
- 필수라는 키워드는 유지
- 병원의 확장 억제
- 일차의료 강화
- 지역의료체계 강화
- 특히, 인력의 수급에 관심

【보건의료 정책변화】

경쟁 vs 질 vs 의료 vs 지역

시사IN

수도권 6600병상이 온다, 지역 의료 붕괴가 가속화된다

'수도권 분원' 설립 예정지 (단위:개)

최소 6600개 병상 증가 전망

병상수

아주대 500 — 경기 파주

인하대 700 — 경기 김포

서울아산 800 — 인천 청라

연세 세브란스 800 — 경기 시흥

서울대 800 — 경기 안산

한양대 미정 — 경기 과천

고려대 500 — 인천 송도

아주대 500 — 경기 평택

경기 남양주 — 고려대 500

경기 하남 — 경희대 500

서울 송파(위례신도시) — 가천대 길병원 1000

블랙홀

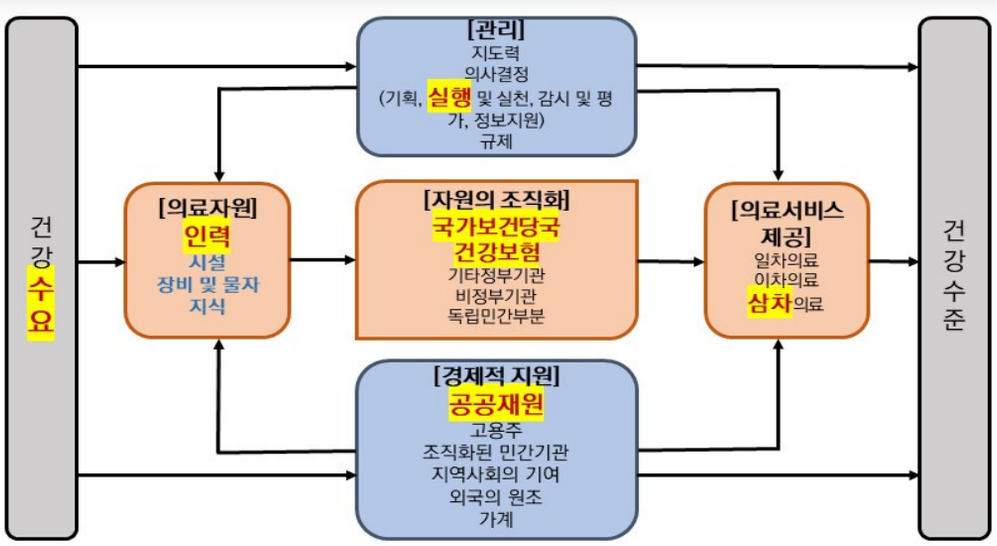
포위/차단

자료: 한국보건사회연구원 신현웅 연구위원

【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

대한민국의 보건의료 정책에 큰 변화가 오고 있습니다.



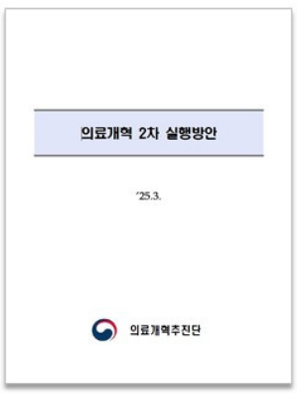
국가보건의료체계 하부구조의 구성요소 Kleczkowski BM. National health systems and their reorientation towards health for all. WHO 1984.

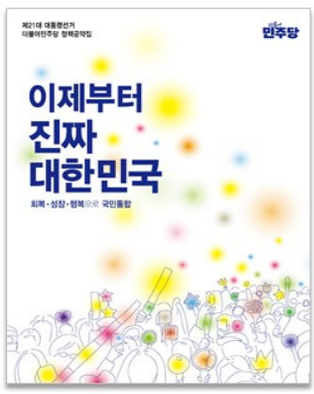
핵심어는 '수요', '인력', '삼차의료', '건강보험', '실행'

【보건의료 정책변화】

최근의 급격한 보건의료정책의 변화: '개혁'







상급종합병원
구조전환

포괄2차
종합병원

공공병원, 공공의대

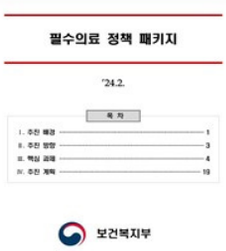
의료대란 해결 및 의료개혁 01

대한민국 어디에서든 제대로 치료받을 수 있도록
지역·필수·공공의료를 살려내겠습니다

【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

정부의 문제 인식: "이제는 말할 수 있다."



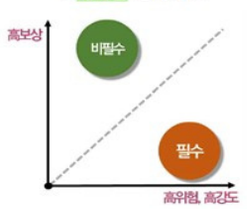
저수가
왜곡된 생태계
필수 분야
전공의

< 문제의 근원: 불공정 의료생태계 >

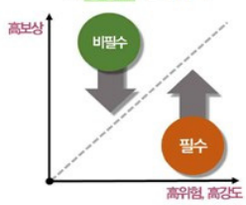
불공정 보상(高위험-低보상)

- 필수(고위험·고난도·당직, 건보 위주) < 비필수(실손보험 + 비급여, 미용 의료 시장 확대)
  - ➡ **필수의료**(지역→수도권) 인력 이탈 → **비필수 분야 인력 흡입**

< 왜곡된 생태계 >



< 정상적 생태계 >



高위험 + 高강도 + 低비전

- **높은 의료사고 부담**(형사, 민사), **의사 수 부족 + 개원 쏠림 심화**
  - ➡ 남은 인력 **번 아웃** → 기존 숙련인력 **이탈↑** + 전공의·전문의 **유입↓**
- 전문의 취득 후 **필수의료** 분야 **좋은 일자리 부족***
  - * 전공의 의존 구조, 중소병원 약화, 진료 外 연구 등 경력경로 다변화 미흡

【보건의료 정책변화】

지불제도의 변화 – 병원 발전전략에 영향



○ **(공급 불균형) 환자의 유출[1], 의료인력·인프라의 수도권 집중[2] 등으로, 지방에는 일정 이상 규모·역량을 갖춘 병원의 부족 발생**

1」 지역 내 의료 이용률('21) : 서울 89.2% vs 충남 66.4%·경북 63.4%

2」 인구 1천명당 의사수 : 서울 3.47명 vs 경북 1.39명 (서울의 40% 수준)

※ **수도권 대학병원으로의 쏠림 가속화**

- **(접근성 개선)** 진료권 폐지('98), KTX 개통('04) 이후 수도권 대학병원에 대한 지방 환자의 공간적 접근성이 크게 개선
  - 급격한 보장성 확대 및 실손보험 활성화로 인한 본인부담 감소는 이전보다 상급병원 이용 문턱을 낮춰서 수도권 대학병원 선호·쏠림 심화
    * (예) 뇌·뇌혈관 MRI 상급종합병원 환자부담금 : (급여화 前) 67만원 → (급여화 後) 18만원
- **(대형화)** 의료자원 투입에 비례한 보상·평가는 배후인구가 많고 의료인력 확보에 유리하여 재투자 여력이 높은 수도권 대학병원의 대형화 가속
  * ('23) 3.8만 병상 → ('29) 4.6만 병상, +7,900개 병상 증가 예상 (9개 병원, 11개 분원 예정)
  - 수도권 대학병원 대형화는 지역의 환자·의료인력 유출을 확대시켜 지역 의료 공백을 심화시키는 악순환 구조 형성
    * (악순환의 고리) 수도권 병상↑ ➡ 지역의 의료인력·환자 유출↑ ➡ 지역의 의료역량↓ ➡ 지역의료의 신뢰도↓ ➡ 지역의 의료인력·환자 유출↑ ➡ …

빅5 쏠림은 문제의 결과임에도 이를 원인으로 지목한 대책을 수립 및 진행 중

【보건의료 정책변화】

지불제도의 변화 – 병원 발전전략에 영향



○ **(지불제도 개혁) 필수의료 위기, 의료전달체계 왜곡, 量에 치중한 의료 공급 등을 초래하는 불합리·불균형한 보상구조 정상화 필요**

	As-Is	To-Be
정책 목표	• 국민이 의료서비스를 "더 많이 이용할수록" 더 많이 보상	➡ • 국민이 의료서비스 이용 후 "더 건강할수록" 더 많이 보상
❶ 수가 결정구조 개편	• 환산지수 계약 기반 획일적 수가 인상 구조	➡ • 획일적 수가 인상 탈피, 상대가치와 연계하여 필수의료 등 저평가 항목 집중인상
❷ 보완형 공공정책수가	• 진료시간 및 의료자원 소모 기반 수가 산정	➡ • 난이도·위험도, 시급성, 진료 외 소요시간(대기·당직) 등 반영
❸ 대안적 지불제도 확대	• 수요 감소 영역은 행위 단위 보상만으로 한계 • 의료 질·성과와 보상 간 연계 부족	➡ • 기관·지역 단위 보상 도입 • 의료 질·성과 기반 보상 등 대안적 지불제도 확대

보상의 단위를 크게, 성과에 기반하여, 기관단위로

【보건의료 정책변화】

지불제도의 변화 – 병원 발전전략에 영향



❷ 성과 중심의 심사·평가체계로 개편

⇨ 심사·평가의 신뢰성·활용성을 높이고 행정부담은 낮춰 보건의료 현장 혁신을 유도하는 개방적·통합적 심사평가로 개편 추진

〈 심사체계 개편 〉

○ **'투입(input) 중심'에서 '성과(outcome) 중심'으로 심사 개선**

- '투입·구조·과정'보다 '성과'를 중시하고, 진료성과를 달성한 기관은 자율성을 존중하는 방향으로 규제 완화(~'28)

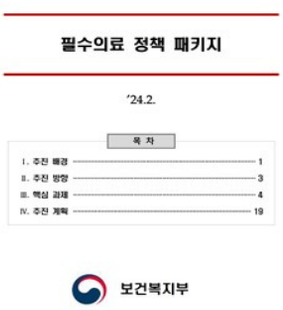
② 평가단위	• '질환·서비스' 단위 평가 → 행위 단위 가산 보상 • 투입·구조지표 위주	➡ • '기관' 단위 평가로 전환 → 기관 단위 별도 보상 • 성과지표 확대
③ 성과보상	• 진료비 지출 규모와 연동되어 의료질평가지원금 제공 • 각종 평가 관련 재원 분산 – 의료질 개선 및 진료성과 달성의 유인 제공에 한계	➡ • 의료질평가지원금은 기관별 진료성과에 비례한 보상 방식으로 전환 • 각종 평가 관련 재원* 통합 * 의료질평가지원금, 적정성평가 가감지급, 종별 가산 등 1.5조 규모 – 성과보상의 획기적 확대로 의료 질 개선의 유인 강화

Pay for performance (P4P)는 세계적 추세이나 측정의 기술적 난제는 아직도 상당함

【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

전문의 중심병원



병원의 체질 개선 및 전환

❶ (전문의 중심 병원) 전공의 의존에서 탈피하여 병원이 전문의 중심으로 안정적으로 운영될 수 있도록 인력구조·운영 단계적 전환

- (기준개선) 의사 배치 법령·지침 개선*으로 충분한 전문의 고용 유도
  * 예: 의료기관 신설 시 의사인력 확보 기준 年 평균 일일 입원환자 20명당 의사 1명 → 전공의는 0.5명으로 산정(의료법 시행규칙 개정)
- (교수확충) 국립대병원 필수의료 전임교수 정원 대폭 확대*('25~), 사립대병원 교수 채용 확대 유도(각종 지정·평가 시 가점 부여 등)
  * 예: 내과·외과·산부인과·소아청소년과·흉부외과·신경외과·신경과·응급의학과 등 우선 확대
- (인센티브) 전문의 고용 확대, 전공의 위임 업무 축소, 병원 인력 간 업무 분담이 더욱 유리하도록 정책 가산 등 보상체계 개선
  * (프랑스) 의사-지원인력 업무 분담 기반 팀 진료 수행 시 인센티브(年 5천 유로)
  · 보상체계 개선 모형 개발('24), 국립대병원·수련병원(비수도권) 등 '전문의 중심 병원 전환 지원사업'('25~'27) 후 단계적 제도화
- (업무분담) 입원전담 전문의 제도 개선, 팀 단위 업무 재설계, 진료지원인력 시범사업 등을 통해 인력 운영 효율화('24)

❸ (업무범위 개선)특위 불필요한 업무부담 개선, 갈등 해소 등을 위해 의료현실에 맞는 합리적 업무 범위 재정립 추진

* 자격·업무 관련 법령·규정 및 의료법 체계 정비, 현장 중심 조정체계 구축

【보건의료 정책변화】

상급종합병원 구조전환 지원사업은 왜 추진한 것인가?



패키지 2 지역의료 강화(지역완결 의료전달체계)

◈ (전달체계) 기능·수요 중심 전달체계 정립 및 필수의료 네트워크 강화

◈ (지역의료 육성) 안정적 인력 확보, 투자 확대, 자원 유출 최소화

□ **기능·수요 중심 협력적 전달체계 전환**

❶ (기능 정립) 상급종합병원, 2차 병원, 전문병원, 의원 등 종별 역할 명확화 및 기능 정립 지원

- (상급종합병원) 중증진료 집중, 진료-연구-교육 등 3대 기능 균형 발전, 국립대병원은 권역 필수의료 중추로 획기적 육성('24~)

  · 일부 상급종합병원은 고도 중증진료병원(4차 병원) 기능 개편 검토

- (2차 병원) 인력 집중화를 통한 중증(심뇌질환 등) 및 중등증 이하 필수의료 기능(입원·수술·응급) 활성화를 위해 지역 2차 병원 체계 개선

4차 병원이라는 용어가 등장한 배경을 생각해 보면

【보건의료 정책변화】

지역·필수·공공의 조직 개편 효과

보건의료정책실

보건의료정책관
- 보건의료정책과
- 의료체계혁신과
- 의료기관정책과
- 약무정책과
- 생명윤리정책과

의료자원정책관
- 의료자원정책과
- 의료인력정책과
- 구강정책과
- 간호정책과
- 혈액장기정책과

한의약정책관
- 한의약정책과
- 한의약산업과

건강보험정책국
- 보험정책과
- 보험급여과
- 건강보험지불혁신추진단
- 보험약제과
- 보험평가과
- 비급여관리팀

보건산업정책국
- 보건산업정책과
- 보건의료기술개발과
- 제약바이오산업과
- 의료기기화장품산업과
- 보건산업해외진출과

첨단의료지원관
- 의료정보정책과
- 의료인공지능데이터정책과
- 재생의료정책과

지역필수공공의료실

지역필수의료정책관
- 지역필수의료총괄과
- 지역의료정책과
- 필수의료정책과
- 지역의료인력양성과

공공의료정책관
- 공공의료정책과
- 국립대병원정책과
- 응급의료과
- 재난의료정책과

건강정책국
- 건강정책과
- 질병정책과
- 건강증진과
- 생활보건팀

정신건강정책관
- 정신건강정책과
- 정신건강관리과
- 자살예방정책과

제2차관

실을 추가로 설치하여 조직 확대 → 정부의 의지

【보건의료 정책변화】

개혁이라고 부르는 정책의 내용



	1차 실행방안(8월)	2차 실행방안(12월)	3차 실행방안('25)
역량 있는 의료인력 확충	· 합리적 인력 수급 추계·조정 체계 구축 · 전공의 수련 혁신 및 국가지원 강화 방안	· 공유협력적 인력 운영 체계 혁신	· 독립적 진료역량 확보 지원 방안
혁신적 전달체계 및 지역의료 재건	· 상급종합병원 구조 전환 · 혁신적 의료 이용·공급 체계 수립 로드맵	· 일차의료 혁신	· 초고령사회 대비 의료전달체계 확충 (회복기·재활, 재택 등)
필수의료 공정 보상체계 확립	· 중증·필수의료 선별·집중 지원방안 · 지불·보상 개혁 로드맵	· 비급여 관리 강화 · 실손보험 구조 개혁	· 미용 시장 관리체계 구축
의료사고 안전망 구축	· 예방·소통 활성화 · 분쟁조정 제도혁신 · 불가항력 사고 보상 강화	· 의료사고처리특례법 · 의료사고 책임·종합 보험·공제 확충 방안	· 추가 쟁점 과제
국민제안 과제	9~10월 의견수렴 (소비자계 협업 FGI)	+ · 국민제안 1차 과제	· 국민제안 2차 과제

◇ **쟁점·이견 큰 과제**는 **세부 이행방안 마련 과정**에서 **추가 의견수렴** 추진

빠르고 과감한 실행 vs 준비되지 않은 섣부름

【보건의료 정책변화】

개혁이라고 부르는 정책의 내용



【 새로운 의료 공급·이용체계 下 2차 병원 육성 방향 】

상급종합병원 — 중증/응급/희귀질환 집중 — 비중증

상종 회송 → 중등도 포괄 + 필수기능 * 24시간 진료 골든타임 필요 진료

2차 병원
- 포괄 + 거점 (포괄 2차병원)
- 필수특화기능 전문화

지역 대부분 의료문제 해결

특정 질환 특화 + 필수기능 24시간 진료/ 골든타임 필요진료

[현행] 2차 병원 기능 모호, 종합병원/병원 형식적 구분 ⇨
[개선] ▲포괄 + 거점 및 ▲필수특화기능 전문화로 기능 전환

의료개혁 2차 실행방안에서는 2차 종합병원의 제기능 수행이 중심

【보건의료 정책변화】

상급종합병원 구조전환 지원사업?



❶ **(상급종합병원 구조전환)** 전공의 의존도 낮추고, 중증·응급·희귀질환 진료 집중할 수 있도록 **진료, 진료협력, 병상, 인력, 전공의 수련 5대 혁신**

< 상급종합병원 5대 혁신 >

- **(진료: 중환자 중심병원)** 환자 중증도 분류체계 개편과 연계, **3년 내 중증진료 비중 (現) 50% → (改) 70% 이상 또는 현행 비중의 50% 상향**
- **(진료협력: 협력 중추병원)** 상급종합병원과 진료협력병원 간 강화된 협력체계 구축, 형식적 의뢰·회송 아닌 '**전문적 의뢰·회송**' 실시
- **(병상: 적정병상 보유 병원)** 허가 **일반병상 적정 감축**, **중환자 병상 확충** 등 최적 중증 입원서비스 제공
- **(인력: 전문인력 중심 병원)** 전문의 및 진료지원간호사 등 **숙련 인력 중심** 운영, 多기관 협력수련 연계 **상급종합병원 전공의 비중 현원 기준 절반** 감축(40→20% 목표 단계적 감축)
  * (1단계) 전문의 쏠림문제 없도록 현 단계에서는 중등증 이하 진료량 감축과 함께 업무 재설계·효율화
  (2단계) 전문의 배출과 연계, 전문의 중심병원으로 전환
- **(전공의 수련: 수련 선도병원)** 多기관 협력 수련 등 협력프로그램 설계 및 관리, **별도 예산 지원**

Volume을 줄이고, 중증·고난도 환자에 집중하라!

【보건의료 정책변화】

상급종합병원 구조전환 지원사업?



❶ **(상급종합병원 구조전환)** 전공의 의존도 낮추고, 중증·응급·희귀질환 진료 집중할 수 있도록 **진료, 진료협력, 병상, 인력, 전공의 수련 5대 혁신**

- **(구조전환 지원사업)** 시범사업을 통해 상급종합병원이 안정적으로 구조 전환할 수 있도록 지원('24.9월~, 3년간) * 세부내용 9월 초 별도 발표

< 시범사업 기준(안) >

- **(진료)** 3년 내 중증진료 비중 70% 이상 또는 현행 비중의 50% 상향
- **(진료협력)** 상급종합병원 + **진료협력병원(병원급 이상 10개), 전문 의뢰·회송** 시행, 협력 진료계획 수립
- **(병상)** ▲서울(허가 1,500병상 이상인 병원: **일반병상 15% 감축** / 그 外: 일반병상 10% 감축) ▲수도권(일반병상 10% 감축) ▲비수도권(일반병상 5% 감축)
  * 어린이 공공전문진료센터, 응급센터, 외상센터 병상은 제외
- **(인력)** 전문의 및 진료지원간호사 업무 재설계 계획, 진료지원간호사 훈련계획 수립, 간호사 업무관련 시범사업 절차 준수 등
- **(전공의 수련)** 다기관 협력 수련 등 협력프로그램 설계 및 관리

상급'종합'병원 vs '상급'종합병원

【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

서울대학교병원을 제외한 국립대학교병원에 대한 통제권한 이관

국립대학병원 설치법

[시행 2026. 1. 2.] [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]

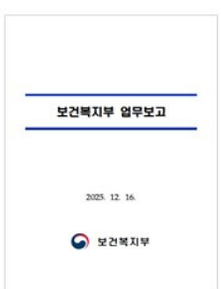
조항	변경 내용
제1호(목적)	"교육기관으로서 자율성을 바탕으로" 추가
제4호(정관)	정관변경의 인가권자를 보건복지부장관으로 변경
제10조(임원), 제14조 대학병원장	이사와 감사, 대학병원장의 임명권자를 보건복지부장관으로 변경
제21조, 제22조, 제23조	사업계획서 및 결산서 제출처와 감독 권한자를 보건복지부장관으로 변경

"할아버지의 재력, 엄마의 정보력, 아빠의 무관심"이라는 벼 있는 농담
국립대병원이 공공성을 최우선 과제로 활동했다면, 현재의 '의료'수준에 있지는 못했을 것

【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

최고, 복격화, 확대, 첨단화 …


보건복지부 업무보고

2025. 12. 16.

보건복지부

[목표3] 지역·필수·공공의료 강화

7 국민중심 의료서비스 제공체계 확립[국정84 · 85]

□ (주요내용) **국립대병원 역량 강화 기반 지역완결 필수의료체계 구축**, 효율적인 의료서비스 제공을 위한 **기능중심 의료기관 전달체계 확립**

○ (**지역완결 필수의료체계**) 지역 필수의료 협력 네트워크 활성화*를 위해 **국립대병원 육성 본격화**, 중앙 협력 下 **지방정부 지역의료 권한·책임 강화****

* 진료협력 등 국립대병원 중심, 지역 공공·민간 의료기관 간 필수의료 협력
** (예) 자원관리·평가·배분 기능 강화, 지역의료 지원조직 확충 등

- (**지방 국립대병원**) **복지부**로 **소관부처 이관** 및 인력·인프라·R&D 등 **패키지 지원 → 권역 내 중증·필수의료 최고병원**으로 **육성**

인력	▸ 전임교원·임상교수 단계적 확충(~'30), 전공의 배정 확대, 처우개선 및 안정적인 교육·연구 환경 조성 등
R&D	▸ 첨단 연구장비·연구비 패키지 지원('25~27, 500억 투자), 산·학·연·병 협력 R&D 및 암·심뇌혈관 등 주요 질환별 연구 네트워크 구축
인프라	▸ 시설·장비 첨단화 및 수술실 확충('26, 812억원), AI 진료시스템 도입('26, 142억원), 노후화된 국립대병원 신축이전 추진 등

지역완결을 국립대병원 역량강화에 '기반'하여 추진하겠다는…

【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

육성, 중추, 인프라, 특별회계, 권한 …



2-1-1 국립대병원 등 필수의료 중추 육성 추진지속

1. 과제 개요

○ 국립대병원을 권역별 필수의료 중추 기관으로 육성하기 위해 ❶인력·인프라 등 역량 제고 지원, ❷총인건비·정원 등 규제개선 추진

- 국립대병원 정책과 지역의료 강화 정책 등의 정합성 제고를 위해 ❸복지부로 소관부처 이관, ❹권역 책임의료기관으로서 권한·기능 강화 추진

출처: 제2차 국민건강보험 종합계획 2026년 시행계획, 2026년 2월

주요 내용

- 전임교수 정원확대, 임상교수 처우개선
- 인프라지원 위한 별도 재원 조성
- 지역 내 최상위 임상적 거버넌스 역할
- 권역 내 협력의 주도 권한 부여

돈과 권한

【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

국립대병원의 다른 말 → 권역책임의료기관



지역의료 격차 해소를 위한 권역책임의료기관 최종치료 역량 강화방안

□ **추진배경**

○ **(배경)** 지역의료 약화의 근본 원인은 환자들이 지역병원을 신뢰하지 못하고 수도권 대형병원 선호·이용 현상 → 원정치료 급증

- 지역의료 위기로 거주지에 따른 치료 가능 사망률 격차(서울vs 충북 12.7%p 差), 막대한 상경진료 비용(年 4.6조원) 발생 중

* (국민 인식조사) "**수도권과 의료격차 심각(81.2%)**", "**국립대병원 역량개선 필요(80.3%)**, 정부지원 필요(80.9%)" 등 **국립대병원 육성 필요성 공감 强**('25.6, 보사연)

○ **(목적)** 붕괴 위기인 지역의료 격차 완화를 위해 조속히 노후화된 권역책임의료기관 시설·장비 인프라 첨단화 필요

* (노후화) "국립대병원 주요 의료장비 120대는 **내구연한** 넘겨 **환자안전에 부정적**"(뉴스1 25.9.)

○ **(지원대상)** 17개 권역책임의료기관 (14개 국립대병원, 3개 사립대병원)

* '25년 총 사업비 2,030억원(국비:지방비:자부담 = 40%:40%:20%, 국비 812억원)

「공공보건의료에 관한 법률」의 용어와 의료전달체계의 용어가 혼용

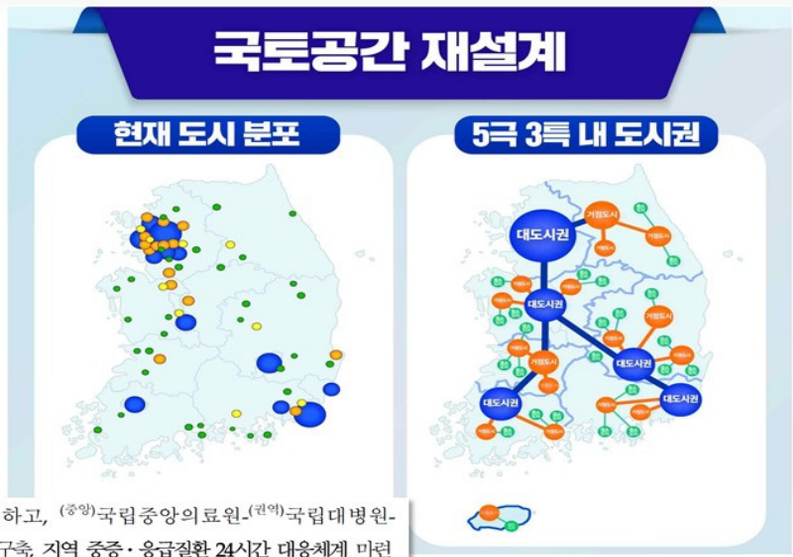
【보건의료 정책변화】

연세대학교 보건대학원

다극 체계로 가려는 큰 움직임 → 의료도 5극?


5극3특 국가균형성장
주진전략 설계도(요약)

2025. 9. 30.

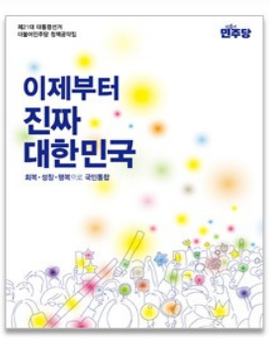


○ **권역별 거점병원**을 **집중** 육성하고, (중앙)국립중앙의료원-(권역)국립대병원-(지역)지방의료원·보건소간 협력체계 구축, **지역 중증·응급질환 24시간 대응체계** 마련

* 국립대병원 24시간 진료체계 지원('26년 126억원), 공공의대 설립과 연계한 권역·지역별 책임의료기관과의 수련·임상협력, 국립대병원-민간병원 연계로 필수·공공의료 전달체계 확립

【보건의료 정책변화】

새정부의 보건의료 정책 (개혁) 방향



- 지역완결은 수도권 쏠림 완화와 같은 의미
- 국립대병원 중심의 지역강화는 빅5 쏠림 완화와 같은 의미

의료대란 해결 및 의료개혁 01

대한민국 어디에서든 제대로 치료받을 수 있도록 지역·필수·공공의료를 살려내겠습니다

필수의료에 대한 충분한 보상체계 확립 및 '지역필수의료기금' 신설

- 중증·응급·소아·분만 등 필수의료 제공 의료기관에 대한 가산 수가 적용
- 지역 내 필수의료 제공 기관에 대한 공공의료 역할 수행 보상체계 강화

지역의사제·지역의대·공공의료 사관학교 신설로 지역·필수·공공의료 인력 확보

- 지역인재 전형 확대와 지역의사제 도입을 통해 부족한 의료인력 확충
- 의대 없는 지역에 의대 신설과 공공의료 사관학교 신설 추진
- 의료인력 양성과정에 대한 국가지원 대폭 확대 및 교육·수련 환경 개선

국립대병원 중심 필수의료 책임 네트워크 구축 및 필수의료 지방분권 확립

- 국립대병원 중심의 권역책임의료기관 통합적 관리체계 일원화 추진
- 시·도 필수의료위원회 중심의 필수의료 정책 추진 체계 마련
- 진료권별 보건의료자원 공급 적정성 평가 및 개선안 마련

【보건의료 정책변화】

새정부의 보건의료 정책 (개혁) 방향



의료대란 해결 및 의료개혁 01

대한민국 어디에서든 제대로 치료받을 수 있도록 지역·필수 공공의료를 살려내겠습니다

▌안심하고 진료할 수 있도록 필수의료 분야 의료사고에 대한 국가책임 강화

- 불가항력 의료사고에 대한 국가보상 확대 및 필수의료 분야 중심의 제도 개선
- 의료인 공제조합 및 공제보험 제도 활성화 지원
- 의료분쟁조정중재원 기능 강화 및 조정·중재 실효성 제고

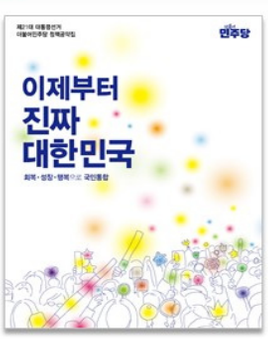
▌진료권 중심 공공의료 인프라 확충

- 공공병원 없는 곳은 신축 및 공공인수 · 공공적 전환 추진
- 공공병원 있는 곳은 적정 규모 증축 · 기능 보강

70개 중진료권을 감안한 공공인프라 확충 – 민간병원의 역할은 애매함

【보건의료 정책변화】

새정부의 보건의료 정책 (개혁) 방향



의료대란 해결 및 의료개혁 02

국민과 함께하는 '진짜 의료개혁'을 추진하고, 보건의료 전문 직역들의 상호협력체계를 강화하겠습니다

▌국민 모두가 참여하는 '국민중심 의료개혁 공론화위원회' 신설

- 공정성·투명성·전문성이 확보되는 의료정책 거버넌스 체계 구축
- 의료인, 전문가, 환자 및 시민대표 모두가 참여하여 사회적 논의·합의 추진

▌국민 모두가 지지하는 '지속가능한 의료개혁 로드맵' 제시

- 의료인력추계위원회 설치·운영, 수련환경평가위원회 등 관련 조직 합리적 개편
- 국민과 의료인 모두 수용 가능한 의료개혁 방안 논의·확정·추진

▌공급자 중심에서 환자 중심으로 의료개혁 추진 방향 설정

- 환자의 권리를 체계적으로 보장하기 위한 법적 근거 마련
- 환자의 건강권 보호, 투병 및 권익 증진을 위한 체계적 정책 확립

▌보건의료 전문직역들의 상호협력체계 강화 및 적정인력 확보

- 전문성과 업무환경을 고려한 보건의료 직역별 업무범위 합리적 설정
- 각 전문 직역의 특수성과 전문성을 기반으로 갈등해소 및 상호협력 체계 구축
- 양질의 의료서비스 제공을 위한 적정인력 기준과 지원체계 마련

경영자 측면으로만 보면 위기(기준 강화)이자 기회(상응하는 보상)

【보건의료 정책변화】

새정부의 보건의료 정책 (개혁) 방향



의료대란 해결 및 의료개혁 03

맞춤형 주치의제를 활성화하고,
방문·재택 진료를 확대하겠습니다

주치의 중심 맞춤형 일차 의료체계 구축

- 환자·질환별 특성을 고려한 주치의 서비스 제공체계 마련
- 의료기관별로 대면진료-비대면진료-방문진료 융합형 서비스체계 도입
- 공동수련 프로그램을 통해 일차 의료 전문의 육성체계 확립
- 단골의원-단골약국 중심의 우리동네 일차의료체계 구축
- 노인층 수요도를 고려한 어르신 대상 한의사 주치의제 도입

주치의제 운영 및 방문·재택 진료에 대한 보상체계 강화

- 노인질환·소아질환 중심 단계별 주치의 등록 활성화로 전국민 주치의제 추진
- 주치의제 활성화를 위한 맞춤형 보상체계 마련 및 방문·재택 진료 수가 현실화
- 등록환자 수와 성과지표 등에 따른 합리적 보상과 인센티브 부여

재택 진료 서비스 및 통합 재가 서비스 제공기관 확대

- 전국적 방문진료 서비스 제공체계 마련, 격오지 집중 지원 모델 수립
- 장기요양 재가·방문 진료 확대를 위한 재택의료기관과 통합재가기관 지정·운영
- 재활·한방 등 특화된 진료과목을 추가하여 재택진료 서비스 다양화 추진
- 편의성·접근성 고려한 방문진료-비대면 모니터링 연계 노인질환 관리체계 구축

일차의료 개혁이 아마도 다음의 개혁 또는 혁신의 주제가 될 것

【보건의료 정책변화】

새정부의 보건의료 정책 (개혁) 방향



초등학생·어르신 돌봄 02

간호·간병 통합서비스 확대와 간병비 건강보험
적용으로 간병부담을 덜겠습니다

간호·간병 통합서비스 확대 및 질 향상

- 공공 의료기관 및 지역 거점병원 전면 확대로 의료서비스 격차 해소
- 300병상 이상 급성기병원 단계적 확대로 수술·중증환자 간병부담 완화
- 서비스 질적 수준 향상을 위한 인력배치 및 평가 기준 개선

요양병원 입원환자에 대한 간병비 건강보험 적용

- 요양병원 간병비 급여화로 사적 간병 부담 완화 및 간병 서비스 질 향상
- 요양병원 입원 등급 결정의 신뢰성 확보 및 부적절한 장기입원 방지대책 마련
- 요양병원형 간호·간병 통합서비스 인력배치 기준 확립

간병인 양성체계 마련하여 간병 질 관리 제고

- 회복기 및 만성기 환자에 적합한 맞춤형 간병서비스 제공
- 간병인 교육과정 수립, 의료기관 직접고용으로 서비스 질 향상 및 환자안전 강화

요양병원과 장기요양시설에 대한 기능 재정립 지원

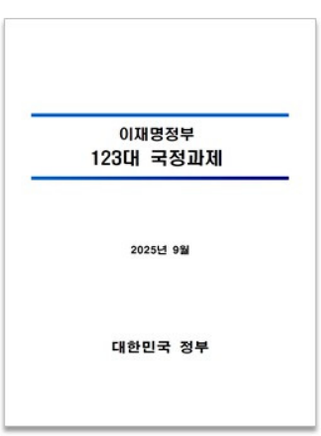
- 장기요양시설 인력기준 및 시설기준 강화
- 장기요양기관 관리운영비 현실화 및 종사자 처우 개선

간병 및 장기요양에 있어서 간호의 역할

부록

【보건의료체계 개혁의 흐름과 간호 프로페셔널리즘】

새 정부도 전 정권의 의료개혁방안을 명시적으로 폐기하지 않았음





■ **전략 3 : 국민건강을 책임지는 보건의료**

[국정83] 지속가능한 보건의료체계로 전환
[국정84] 지역격차 해소, 필수의료 확충, 공공의료 강화
[국정85] 일차의료 기반의 건강·돌봄으로 국민 건강 증진
[국정86] 국민 의료비 부담 완화

'공공'이 추가된 외에는 별반 다른 것이 없음

【보건의료체계 개혁의 흐름과 간호 프로페셔널리즘】

과거의 의료'개혁'과 무엇이 다른가?



< 의료혁신위원회 의제 최종(안) >

3개 분야	10개 의제
지역·필수·공공 의료 강화 (3)	▸ 응급·분만·소아 등 필수의료 강화 및 의료사고 안전망 구축 ▸ 지역·필수·공공의료를 위한 미래 보건 의료인력 양성 ▸ 공공의료기관 확충 및 역량 제고
초고령사회 대비 보건의료 체계 구축 (3)	▸ 재가 중심 의료·돌봄 체계 구축 및 임종 돌봄 환경 조성 ▸ 간호·간병통합서비스 확대 및 간병서비스 질 제고 ▸ 예방 중심 보건 의료체계 구축
미래환경 대비 지속가능성 제고 (4)	▸ 보건의료 재정·인력 등 보건의료 정책 거버넌스 확립 ▸ 지속 가능한 국민 의료비 관리체계 마련 ▸ 기후변화·팬데믹 등 위기 대응을 위한 보건의료 체계 구축 ▸ 보건의료 AI·디지털 전환 체계 구축

급박한 필수의료 논점에서 확대하여 전반적인 보건의료체계로 접근
과거의 1,2차 의료개혁안의 연장선
상급종합병원 구조전환이나 포괄2차병원 등 이미 시행되는 제도(사업)는 언급이 적음

【보건의료체계 개혁의 흐름과 간호 프로페셔널리즘】

과거의 의료'개혁'과 무엇이 다른가?



분야	의제(안)	의제 최종(안)
지역·필수·공공 의료 강화 (3)	▸ **응급·분만·소아 등 필수의료 강화 및 의료사고 안전망 구축** - 응급·분만·소아 등 필수의료 강화를 위한 중앙-지방-의료기관 역할·권한 명확화 및 시스템·인프라 마련 - 응급실 환자 수용 및 배후 진료 역량 강화 · 응급의학과 중심 의료체계 개선 및 배후 진료과 인력 확보 - 환자·의료진 모두를 위한 국가책임 의료사고 안전망 구축	▸ **응급·분만·소아 등 필수의료 강화 및 의료사고 안전망 구축** - 응급·분만·소아 등 필수의료 강화를 위한 중앙-지방-의료기관 간 역할 정립 및 시스템·인프라 구축 - 응급실 환자 수용 및 배후 진료 역량 강화 - 환자·의료진 모두를 위한 국가책임 의료사고 안전망 구축
	▸ **지역·필수·공공의료를 위한 미래 보건의료인력 양성** - 지역의사제·공공의대 등 취약지역 의료인력 육성·지원 방안 - 보건의료 분야 종사자 교육·배치 국가관리 - 의료인력 간 역할 분담 및 인력 수급 체계 정비	▸ **지역·필수·공공의료를 위한 미래 보건의료인력 양성** - 지역의사제·공공의대 등 공공의료 인력 육성·지원 방안 - 보건의료 분야 종사자 교육·배치 국가 관리 - 의료인력 간 역할 분담 및 인력 수급 체계 정비
	▸ **공공의료기관 확충 및 역량 제고** - 공공의료 개념·역할 재정립 - 공공병원 확충 및 기능 중심 역량 강화	▸ **공공의료기관 확충 및 역량 제고** - 공공의료 개념, 역할, 주요 지원 분야 등 정립 - 공공병원 확충 및 기능 중심 역량 강화

【보건의료체계 개혁의 흐름과 간호 프로페셔널리즘】

과거의 의료'개혁'과 무엇이 다른가?



분야	의제(안)	의제 최종(안)
초고령사회 대비 보건의료 체계 구축 (3)	▸ **재가 중심 의료·돌봄 체계 구축 및 임종 돌봄 환경 조성** - 의료-복지 연계 강화를 위한 다학제 협력 기반 통합돌봄 체계 구축 - 재택의료·간호센터 및 공공형 통합방문 의료·간호센터 확충을 통한 예방-치료-재활-완화 전 주기 관리체계 구축 - 호스피스·연명의료 제도 개선 등 생애 말기 의료 제공체계 강화	▸ **재가 중심 의료·돌봄 체계 구축 및 임종 돌봄 환경 조성** - 의료-복지 연계 강화를 위한 다학제 협력 기반 통합돌봄 체계 구축 - 재택의료·간호센터 및 공공형 통합방문 의료·간호센터 확충 등을 통한 예방-치료-재활-완화 전 주기 관리체계 구축 - 호스피스·연명의료 제도 개선 등 생애 말기 의료·돌봄 제공체계 강화
	▸ **간호·간병통합서비스 확대 및 간병 서비스 질 제고** - 간호·간병통합서비스 전면 확대 및 간병인 급여·교육 체계 국가 관리(간병 국가책임제) 등을 통한 서비스 質 제고 방안	▸ **간호·간병통합서비스 확대 및 간병 서비스 질 제고** - 간호·간병통합서비스 확대 및 내실화 - 요양병원 등 간병비 급여화 및 전문화 - 간병인 급여·교육 체계의 국가 관리 기반 마련 및 지역사회 돌봄 연계
	▸ **예방 중심 보건 의료체계 구축** - 치료 중심에서 예방 중심으로 패러다임 전환 - 사전 예방적 건강증진체계 강화 및 예방 중심의 보상체계 전환	▸ **예방 중심 보건 의료체계 구축** - 치료 중심에서 예방 중심으로 패러다임 전환 - 사전 예방적 건강증진체계 강화 및 예방 중심의 보상체계 전환

【보건의료체계 개혁의 흐름과 간호 프로페셔널리즘】

과거의 의료'개혁'과 무엇이 다른가?



분야	의제(안)	의제 최종(안)
미래환경 대비 지속가능성 제고 (4)	▸ **보건의료 재정·인력 등 보건의료 정책 거버넌스 확립** - 보건의료 정책 지방분권 등 중앙-지방정부 간 역할 정립 및 재정 분담, 지역사회 민관 협력체계 육성	▸ **보건의료 재정·인력 등 보건의료 정책 거버넌스 확립** - 신뢰 기반의 보건의료 거버넌스 구축 - 보건의료 정책 지방분권 등 중앙-지방정부 간 역할 정립 및 재정 분담 - 지역사회 민관 협력체계 육성
	▸ **지속 가능한 국민 의료비 관리체계 마련** - 수가·보상체계 등 지불·보상 구조 개혁을 통한 전달체계 정상화 - 비급여 관리 의료 공급·이용 적정화 방안	▸ **지속 가능한 국민 의료비 관리체계 마련** - 수가·보상체계 등 지불·보상 구조 개혁을 통한 전달체계 정상화 - 비급여 관리(실손보험 등), 의료 공급·이용 적정화 방안
	▸ **기후변화·팬데믹 등 위기 대응을 위한 보건의료 체계 구축** - 기후변화 관련 의료분야 탄소중립, 감염병 대응체계 고도화 및 인프라·인력 확충 방안	▸ **기후변화·팬데믹 등 위기 대응을 위한 보건의료 체계 구축** - 기후변화 관련 의료분야 탄소중립 방안 - 감염병 대응체계 고도화 및 인프라·인력 확충 방안
	▸ **AI·기술 혁신 등 미래 혁신형 보건의료 체계 구축** - AI·디지털 신기술 도입을 통한 의료 시스템 혁신 - 기술 활용을 통한 지역 격차 완화 및 의료 이용·공급 효율화	▸ **보건의료 AI·디지털 전환 체계 구축** - AI·디지털 신기술 도입을 통한 의료 시스템 혁신 - AI 등 기술 활용을 통한 지역 격차 완화 및 의료 이용·공급 효율화


경청해 주셔서 감사합니다.
Severance
With the Love of God, Free Humankind from Disease and Suffering
SEVERANCE HOSPITAL